Sykehusets logo	Studierelatert tillegg til prosedyre i perioden hvor The Norwegian Labour Care Guide Trial (NORWELCG) pågår	
Dokumentansvarlig:		
Godkjent av:		
Gyldighetsområde:		

The Norwegian WHO Labour Care Guide Trial (NORWELCG)

Avdelingen er med i en stepped wedge cluster randomisert studie; The Norwegian WHO Labour Care Guide Trial (NORWELCG). Studien starter med en kontroll periode før en intervensjonsperiode for alle deltagende avdelinger. I kontrollperioden benyttes avdelingens eksisterende prosedyre som omhandler fremgang i fødsel. I intervensjonsperioden vil det ved alle fødsler med behov for et partogram benytte anbefalingene for *The Labour Care Guide (LCG)*. Denne prosedyren er et tillegg til avdelingens eksisterende prosedyrer som omhandler fremgang i fødsel og benyttes i intervensjonsperioden

Studieperiode: 1. april 2025 – 26. mai 2026

1. Hensikt

Formålet med denne prosedyren er å sikre at alle medarbeidere på fødeavdelingen kjenner til prinsippene i the *Labour Care Guide*:

- Veilede overvåkning og dokumentasjon av kvinners og barns velvære samt progresjon i fødselen
- Veilede kvalifisert helsepersonell i å tilby støttende omsorg gjennom hele fødselen for å sikre en positiv fødselsopplevelse for kvinner
- Hjelpe kvalifisert helsepersonell med å raskt identifisere og håndtere oppståtte komplikasjoner under fødselen, ved å gi referanseverdier for observasjoner som skal utløse refleksjon og spesifikke tiltak dersom en unormal observasjon oppdages.
- Forebygge unødvendig bruk av intervensjoner under fødselen.
- Støtte revisjon og kvalitetsforbedring

Og er godt kjent med seksjonene omhandlende overvåking av fødsel og vurdering av fremgang i fødsel, dokumentasjon av faglige vurderinger og samvalg.

2. Omfang

Gjelder for jordmødre og leger ved fødeavdelingen ved [avdelingens navn] under studieperioden med NORWELCG.

Prosedyren vil være gjeldende for alle kvinner som planlegger å føde vaginalt ved avdelingen. Alle kvinner skal ha et registreringsark merket med kvinnens ID. Dokumentasjon under fødsel foregår som rutine i avdelingens journalsystemer samt på registreringsarket.

Enhver fødsel vil følges opp og behandling iverksettes etter hva som vurderes å være god klinisk praksis uavhengig av om avdelingen er i kontroll- eller intervensjonsperiode.

Sykehusets logo	Studierelatert tillegg til prosedyre i perioden hvor The Norwegian Labour Care Guide Trial (NORWELCG) pågår	
Dokumentansvarlig:		
Godkjent av:		
Gyldighetsområde:		

REK har godkjent passivt samtykke for deltagelse. Informasjonsskriv om studien sendes ut via lenke med innkalling til rutine ultralyd. Lenken linkes til studiens nettside, med informasjonsskriv tilgjengelig på 13 ulike språk. Informasjonsskrivet vil også være tilgjengelig på plakater i avdelingen med QR kode. QR koden er linket til studiens nettside med informasjonsskriv tilgjengelig på 13 ulike språk.

LCG er et «monitoring-to action tool" det innebærer overvåking av mor og barn, at funn fra observasjoner og undersøkelser vurderes opp mot referanseverdier, at planer for videre oppfølging legges sammen med kvinnen og at planene dokumenteres og tiltak/handlinger gjennomføres. LCG vektlegger respektfull omsorg, god kommunikasjon, støtte og kontinuerlig omsorg gjennom fødselen.

3. Labour Care Guide består av syv seksjoner hvorav tre er "nye" sammenlignet med dagens praksis. Disse er**: 2; dokumentasjon av støttende omsorg, 5; vurdering av fremgang i fødsel og 7; samvalg,** som inngår i NORWELCG studien for å undersøke effekten av LCG i en norsk kontekst.

Seksjon 2: Dokumentasjon av støtteperson

Seksjon 5: Vurdering av fremgang i fødsel.

- LCG definerer langsom fremgang, men legger ikke føringer for behandling.
- Definisjon av aktiv fødsel: Aktiv fødsel defineres fra 5 cm mormunns åpning, tilnærmet avflatet cervix og regelmessige rier. Partogram kan åpnes før aktiv fase er definert, men anbefalingene fra LCG gjelder for aktiv fase av fødsel.
- Varslings- og tiltakslinjer: Skal ikke brukes og fjernes manuelt på hvert elektroniske partogram [gjelder Partus].
- Definisjon av langsom fremgang: I intervensjonsperioden defineres langsom fremgang etter følgende tidsintervall:
    - 5-6 cm = ≥6 timer
    - 6-7 cm = ≥5 timer
    - 7-8 cm = ≥3 timer
    - 8-9 cm = ≥2,5 timer
    - 9-10 cm = ≥2 timer

- I andre stadium (fra cervix er utslettet til barnet er født): Mer enn 3 timer hos førstegangsfødende, og mer enn 2 timer hos flergangsfødende, det vil si inkludert passiv og aktiv fase (nedtrenging og trykketid).
- Trykketid: ≥60 minutter defineres som langsom fremgang (i henhold til NGF Veileder i fødselshjelp)

Seksjon 7: **Samvalg**

LCG anbefaler at kvinnen involveres i diskusjoner og kan ta informerte valg om håndtering av fødselen, planer som legges, og tiltak (samvalg). LCG vektlegger samvalg gjennom kontinuerlig kommunikasjon med kvinnen og hennes partner, og dokumentasjon av vurderinger og planer underveis i fødselsforløpet. I studieperioden samles data om samvalg ved:

- Fremgang i fødsel
- Fosterovervåking
- Smertelindring
- Vaginal undersøkelse
- Episiotomi
- Mobilitet/fødestilling
- Operativ forløsning
- Oxytocin post partum
- K-vit til nyfødt

4. Fremgangsmåte i studieperioden

Kontrollperiode (1. april 2025 – [Sluttdato]

- Eksisterende prosedyre ved fremgang i fødsel som inkluderer WHO partogrammet benyttes.
- *Registrering av data*: Overvåking og behandling dokumenteres gjennom hele fødselsforløpet etter avdelingens gjeldende rutiner. Et registreringsark med studiespesifikk informasjon fylles fortløpende ut av jordmor gjennom hele fødselsforløpet og legges etter avsluttet fødsel på [avtalt plass].

Intervensjonsperiode [Startdato] – [Sluttdato]

Sykehusets logo	Studierelatert tillegg til prosedyre i perioden hvor The Norwegian Labour Care Guide Trial (NORWELCG) pågår	
Dokumentansvarlig:		
Godkjent av:		
Gyldighetsområde:		

- *Punkt 3 i denne prosedyren tas i bruk og prinsippene i LCG (presentert i punkt1) ligger til grunn.* Alle planlagte vaginale fødsler skal følge anbefalingene i punkt 3. Dette er et tillegg til eksisterende prosedyrer.
- *Registrering av data:* Overvåking og behandling dokumenteres gjennom hele fødselsforløpet etter avdelingens gjeldende rutiner samt på et registreringsark med studiespesifikk informasjon, fylles fortløpende ut av jordmor og legges etter avsluttet fødsel på [avtalt plass].
- *Labour View* fra Laerdal Medical kan benyttes som et hjelpemiddel for å kalkulere frem tidspunkt for når langsom fremgang defineres. Data registrert i *Labour View* lagres ikke i kvinnens journal.

5. Etter fødsel i kontroll og intervensjonsperiode

- **Registreringsarket** oppbevares i henhold til lokale rutiner [avtalt plass]. Lokal koordinator registrerer data i web CRF, skanner deretter arket og arkiverer det i kvinnens journal.
- **Reservasjon av data**: Kvinner som ikke ønsker at hennes opplysninger fra fødsel benyttes i studien, signerer på informasjonsarket. Kvinnen beholder originalen, kopi av denne oppbevares i henhold til lokale rutiner [avtalt plass]. Lokal koordinator skanner og arkiverer arket i kvinnens journal og sørger for at opplysningene ikke registreres i web CRF.

6. Referanser

[Legge til prosedyrer fra avdelingen]. WHO. (2020) WHO labour care guide: user`s manual. In WHO (Ed.), WHO int. (1 ed., pp. 1-34) https://www.who.int/publications/i/item/9789240017566: WHO.

Metodebok Stimulering av rier (2022)